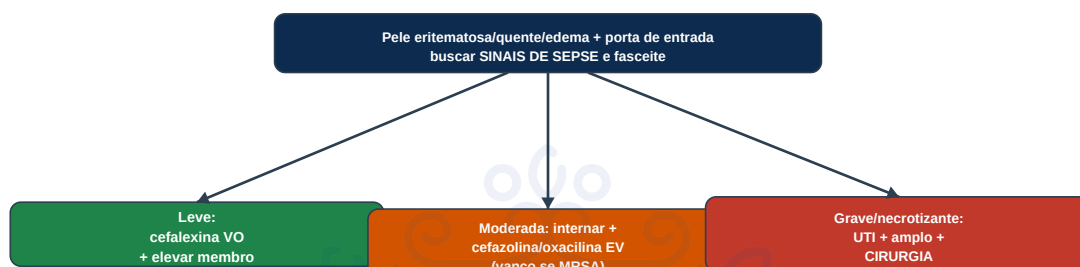


CELULITE x ERISIPELA — GRAVIDADE GUIA ATB

FLUXOGRAMA — GRAVIDADE GUIA A CONDUTA

CELULITE/ERISIPELA — ESTRATIFICAR -> ATB



CELULITE x ERISIPELA

Aspecto	Erisipela	Celulite
Profundidade	Derme (mais superficial)	Derme + subcutâneo (mais profunda)
Bordas	BEM delimitadas, elevadas ('em degrau')	MAL delimitadas, difusas
Aspecto	Vermelhidão intensa, brilhante ('casca de laranja'), crescimento rápido	Vermelhidão difusa, evolução mais indolente
Agente	Estreptococo beta-hemolítico do grupo A	S. aureus + Estreptococo

AValiação e porta de entrada

O QUE BUSCAR

- Anamnese: início/evolução, localização, dor; PORTA DE ENTRADA (trauma, ferida cirúrgica, MICOSE interdigital/frieira, picada, úlcera venosa); comorbidades (DM, insuficiência venosa, linfedema, obesidade)
- Exame: sinais vitais; inspeção (extensão, limites, edema); palpação (calor, FLUTUAÇÃO = abscesso, CREPITAÇÃO = alerta); pulsos/perfusão; linfonodos regionais
- DEMARCAR a borda da lesão com caneta para monitorar a evolução
- Buscar e tratar a porta de entrada (antifúngico para frieira, curativo para feridas)
- Diferencial: TVP (edema assimétrico), fascíte necrotizante, abscesso

SINAIS DE ALERTA

INVESTIGAÇÃO IMEDIATA

- Febre alta ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) ou hipotermia; taquicardia/taquipneia/hipotensão (SEPSE); alteração do nível de consciência
- Dor DESPROPORCIONAL, progressão rápida, crepitação, bolhas hemorrágicas, necrose = FASCEÍTE NECROTIZANTE (emergência cirúrgica)
- Lesão em FACE (risco de trombose de seio cavernoso)
- Imunossupressão/diabetes descompensado; falha após 48-72h de ATB correto
- Crepitação ou gás nos tecidos no RX -> gangrena/fasceíte

TRATAMENTO POR GRAVIDADE

Rx ATB + MEDIDAS DE SUPORTE

LEVE (ambulatorial): Cefalexina 500 mg VO 6/6h por 7-10 dias (alérgico: Clindamicina 300 mg 8/8h); analgesia (Dipirona) $\pm$ AINE

MODERADA (internação): Cefazolina 1-2 g EV 8/8h ou Oxacilina 2 g EV 4/4h; se risco de MRSA -> Vancomicina 15-20 mg/kg EV 12/12h (ou Linezolida); transição VO em 48-72h de melhora

GRAVE/necrotizante: UTI + avaliação CIRÚRGICA imediata; cobertura ampla — Vancomicina + Piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6h (ou Meropenem)

Suspeita de FASCEÍTE: ADICIONAR Clindamicina 600-900 mg EV 8/8h (inibe a produção de toxinas)

Suporte: ELEVAÇÃO do membro (fundamental), compressas frias, analgesia, tratar a porta de entrada, profilaxia de TVP se imobilidade

Exames (moderado/grave): hemograma, PCR, função renal, glicemia; hemocultura se febre/sepse; US-Doppler se suspeita de abscesso/TVP; TC/RM se fasceíte

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: grave/extensa, sinais sistêmicos (febre alta/taquicardia/hipotensão), comorbidade descompensada, imunossupressão, falha ambulatorial (piora em 48-72h), suspeita de infecção profunda (abscesso/fasceíte), lesão facial, sem condição de seguimento, necessidade de ATB EV
- ☐ ALTA: lesão estabilizada/em regressão (não ultrapassa a marca), afebril $\geq 24\text{h}$, melhora da dor, deambulando (se MMII), tolerando VO, comorbidades controladas, retorno em 48-72h
- ☐ Receita: Cefalexina/Amox-clav (ou Clindamicina se alérgico) + analgesia; manter o membro elevado
- ☐ Alarme (retorno imediato): vermelhidão ultrapassa a marca da caneta, febre persistente, bolhas/necrose, piora da dor, confusão
- ☐ Diabéticos: controle glicêmico rigoroso e seguimento

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com celulite/erisipela em ____ há ____ dias; bordas ____ (definidas/difusas); extensão ____ cm; porta de entrada ____.
- Gravidade: febre ____, sepse ____, bolhas/necrose/crepitação ____ (fasceíte?); comorbidades (DM/imunossupressão) ____.
- Conduta: ATB ____ iniciado às ____, elevação do membro, analgesia; demarcação feita; exames ____.
- Solicito internação enfermaria/UTI / avaliação cirúrgica (necrose/fasceíte); resposta ao tratamento ____.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual característica diferencia a erisipela da celulite?

- A) Bordas mal delimitadas e difusas
- B) Bordas BEM delimitadas e elevadas ('em degrau'), mais superficial (derme), por estreptococo do grupo A
- C) Acomete músculo e osso
- D) É sempre indolor
- E) Não tem porta de entrada

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado sugere fascíte necrotizante e exige avaliação cirúrgica de emergência?

- A) Eritema leve sem dor
- B) Dor desproporcional, progressão rápida, crepitação, bolhas hemorrágicas e necrose
- C) Febre baixa isolada
- D) Edema simétrico
- E) Prurido

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o tratamento da celulite/erisipela LEVE (ambulatorial)?

- A) Vancomicina EV
- B) Cefalexina 500 mg VO 6/6h (alérgico: clindamicina), com elevação do membro
- C) Meropenem EV
- D) Apenas compressas
- E) Antifúngico oral

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Na suspeita de fascíte necrotizante, qual antibiótico se ADICIONA pela ação antitoxina?

- A) Azitromicina
- B) Clindamicina (inibe a produção de toxinas bacterianas)
- C) Fluconazol
- D) Cefalexina
- E) Doxiciclina

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual medida de suporte é fundamental no tratamento da celulite/erisipela de membro inferior?

- A) Manter o membro pendente
- B) Elevação do membro afetado
- C) Imobilização gessada
- D) Compressas quentes contínuas
- E) Restrição hídrica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A erisipela é mais superficial (derme), tem bordas bem delimitadas e elevadas ('em degrau'), aspecto brilhante e é causada pelo estreptococo do grupo A; a celulite é mais profunda e de bordas difusas.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Dor desproporcional, progressão rápida, crepitação, bolhas hemorrágicas e necrose sugerem fascíte necrotizante — emergência cirúrgica (desbridamento) com ATB de amplo espectro + clindamicina.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A forma leve trata-se ambulatorialmente com cefalexina VO (clindamicina se alérgico), elevação do membro e analgesia, demarcando a lesão para acompanhamento.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A clindamicina é adicionada na suspeita de fascíte por inibir a produção de toxinas bacterianas, além do esquema de amplo espectro e do desbridamento cirúrgico.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A elevação do membro afetado é medida de suporte fundamental, reduzindo o edema e favorecendo a resposta ao tratamento.

SM24
Suporte ao Plantão Médico